HIPERTENSIÓN PORTAL \ BAZO \ ESPLENECTOMIA/ TRANSPLANTE

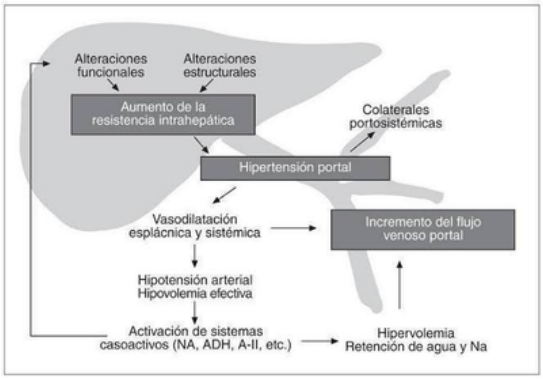
DRA. LIZKA RICHARDS

DEFINICIÓN Y CAUSAS

- Es el aumento de la presión portal por encima de 12mmHg, o un gradiente mayor a 7mmHg (diferencia entre la porta y la vena cava inferior).
- Intrahepáticas: cirrosis (la más frecuente), hiperplasia nodular regenerativa, tumores benignos de gran volumen, hepatitis, drogas o toxinas, enfermedad venoclusiva.
- Prehepáticas: trombosis portal o esplénica, shunt arterioportal.
- Posthepáticas: síndrome de Budd-Chiari, falla cardíaca.

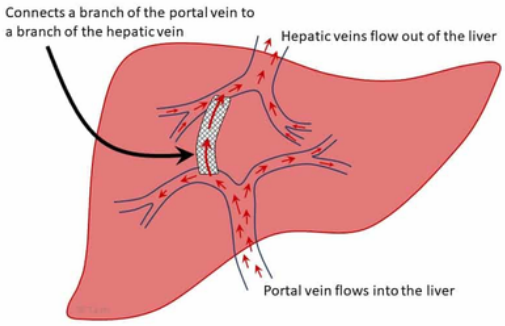
FISIOPATOLOGÍA

- La injuria hepática causa necrosis; si la regeneración se ve afectada (por destrucción de la trama reticular o malnutrición), se forman fibrosis y nódulos de regeneración en vez de tejido normal, lo que distorsiona la vasculatura y produce hipertensión portal.



DECOMPRESIÓN Y TRASPLANTE HEPÁTICO

- Si el manejo de primera línea falla: TIPS (derivación portosistémica transyugular), derivación esplenorrenal distal, o trasplante hepático.
- Se trasplanta cuando la sobrevida al año con l trasplante es mayor que la sobrevida sin él.



MANIFESTACIONES CLÍNICAS

- Hemorragia digestiva por várices esofágicas (33%): hematemesis indolora y masiva.
- Ascitis y encefalopatía aguda/crónica (síndrome neuropsiquiátrico reversible).
- Esplenomegalia con hiperesplenismo: hemólisis, trombocitopenia y leucopenia.
- Síndrome hepatorrenal y síndrome hepatopulmonar.

OTRAS COMPLICACIONES

- Ascitis, encefalopatía hepática e hiperesplenismo/esplenomegalia (hemólisis, trombocitopenia y leucopenia).

ESPLENECTOMÍA EN EL CIRRÓTICO

- Solo de forma simultánea durante el trasplante hepático, no aislada mientras está en lista de espera.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VÁRICES

- Diagnóstico: laboratorios (trombocitopenia, PFH, INR), USG Doppler (esplenomegalia, dilatación portal, colaterales), angio-TC y endoscopia (várices).
- Tratamiento de la hemorragia por várices: reanimación, terapia endoscópica (escleroterapia o ligadura, >90% de éxito), betabloqueadores o nitratos; mortalidad de la hemorragia digestiva alta: 30%.

HIPERTENSIÓN PORTAL/BAZO,/ESPLENECTOMÍA / TRASPLANTE

DRA. LIZKA RICHARDS

INDICACIONES DE TRASPLANTE Y CHILD-PUGH

- Categorías: hepatocelular (viral, etílica, autoinmune, NASH), vascular (Budd-Chiari), colestásica (cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante, atresia biliar), errores del metabolismo (Wilson, hemocromatosis), hepatitis fulminante.
- Child-Pugh: A (1-6 puntos, sobrevida >85%), B (7-9, 60%), C (10-15, 40%).

PUNTAJE MELD

- Mortalidad en lista de espera a 3 meses según bilirrubina, creatinina e INR.

ISQUEMIA FRÍA

- Máximo 8 horas en solución de preservación a 4 °C (Custodiol).

ISQUEMIA CALIENTE

- Máximo 80 minutos (1 h 20 min) para completar las anastomosis vasculares y evitar elevación masiva de transaminasas o fallo primario del injerto.

Tabla 1. Indicaciones de trasplante hepático.

1. Insuficiencia hepática aguda fulminante (hepatitis fulminante)
◦ Hepatitis viral por virus A, B/D, C, E, herpes simplex ◦ Hepatotoxicidad (tóxicos directos, fármacos o drogas) ◦ Hepatitis autoimmune ◦ Enfermedad de Wilson ◦ Otras: isquemia, esteatosis gravídica, sindromes HELLP y Budd-Chiari, neoplasias ◦ Etiología indeterminada
2. Cirrosis hepática
• **Hepatocelular**
◦ Hepatitis C ◦ Hepatitis B ◦ Hepatitis autoimmune ◦ Alcohol
• **Colestáticas**
◦ Cirrosis biliar primaria ◦ Cirrosis biliar secundaria ◦ Colangitis esclerosante primaria ◦ Atresia de vías biliares ◦ Síndrome de Alagille ◦ Ductopenia no sindrómica ◦ Fibrosis quística
• **Metabólicas**
◦ Deficiencia de alfa-1-antitripsina ◦ Enfermedad de Wilson ◦ Esteatohepatitis no alcohólica ◦ Hemocromatosis hereditaria ◦ Hemocromatosis neonatal ◦ Tirosinemia ◦ Glucogenosis tipo IV
• **Criptogénicas**
3. Defectos genéticos de origen hepático
◦ Polineuropatía amiloidótica familiar ◦ Hipercolesterolemia familiar homocigota ◦ Hiperoxaluria primaria tipo I
4. Tumores hepáticos malignos
• **Primitivos**
◦ Hepatocarcinoma ◦ Hepatoblastoma ◦ Hepatocarcinoma fibrolamelar ◦ Hemangioendotelioma epitelioide ◦ Colangiocarcinoma
• **Metastásicos**
◦ Tumores neuroendocrinos
5. Misceláneas
Poliquistosis hepática Síndrome de Budd-Chiari Telangiectasia hemorrágica hereditaria